



MALETÍN DE RESPUESTA RÁPIDA MÓVIL

Primer Respondedor en Motocicleta

Contenido esencial y protocolos de atención con base en evidencia científica

Paro cardiorrespiratorio	Trauma y hemorragia	Obstrucción de vía aérea	Anafilaxia
Crisis hipertensiva / Hipoglucemia	Convulsiones	Referencias	Lista de verificación

ADVERTENCIA: Uso exclusivo del personal certificado en Respuesta Rápida y Emergencias Prehospitalarias. No debe ser utilizado por personas sin la capacitación correspondiente.

Versión: 1.1 — 2025

Adaptado para el Perú

Base: Guías internacionales
vigentes

RESUMEN DEL MALETÍN

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
Peso máximo	No mayor a cinco kilogramos incluyendo el maletín	Transportable en motocicleta sin afectar el manejo
Acceso rápido	Bolsillos externos identificados por color	Apertura en menos de diez segundos por sección
Reposición	Lista de verificación después de cada intervención	Maletín listo antes de 60 minutos luego del uso
Evidencia	Asociación Americana del Corazón 2020, Consejo Europeo de Reanimación 2021, Soporte Vital Avanzado en Trauma 10. ^a edición	Protocolos internacionales vigentes

Organización por bolsillos — identificados por color

BOLSILLO	COLOR	TIPO DE EMERGENCIA	CONTENIDO PRINCIPAL	PESO ESTIMADO
A	Rojo	Paro cardiorrespiratorio	Mascarilla de reanimación y desfibrilador externo automático	Según equipo disponible
B	Naranja	Trauma y hemorragia	Torniquete, vendaje hemostático y manta isotérmica	Aprox. 800 g
C	Azul	Obstrucción de vía aérea	Cánulas, bolsa de ventilación manual y oxígeno portátil	Aprox. 1,2 kg
D	Morado	Anafilaxia, convulsiones y crisis	Medicamentos de emergencia y material de venopunción	Aprox. 600 g
E	Verde	Hipoglucemia, crisis hipertensiva y monitoreo	Glucómetro, tensiómetro, oxímetro de pulso y glucosa oral	Aprox. 400 g

SECCIÓN 1 — PARO CARDIORRESPIRATORIO

PRIORIDAD ABSOLUTA — Reanimación cardiopulmonar de alta calidad y desfibrilador externo automático en menos de 3 minutos. Fuente: Guías de la Asociación Americana del Corazón 2020.

Equipamiento — Bolsillo A (color rojo)

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD
Mascarilla de reanimación de bolsillo con válvula unidireccional	1 unidad
Guantes de nitrilo descartables talla mediana	4 pares
Guantes de nitrilo descartables talla grande	4 pares
Desfibrilador externo automático (DEA) portátil	Con parches para adulto y para niño. 1 equipo con batería cargada.
Parches de repuesto para el desfibrilador externo automático	1 juego para adulto y 1 juego pediátrico
Hoja de registro rápido de reanimación	Con campos para hora de inicio, tiempos de descarga y medicamentos. 2 copias.
Lapicero negro indeleble	1 unidad

Protocolo — Reanimación Cardiopulmonar Básica

Basado en las Guías de la Asociación Americana del Corazón 2020 y el Consejo Europeo de Reanimación 2021.

1	Verificar la seguridad de la escena antes de acercarse al paciente. Colocarse los guantes de nitrilo.
2	Evaluar la respuesta del paciente: tocar los hombros firmemente y gritar '¿Está usted bien?'. Sin respuesta → activar de inmediato el Sistema de Emergencias Médicas (SAMU 106 o central local).
3	Verificar la respiración y el pulso carotídeo de forma simultánea durante no más de 10 segundos. Si no hay pulso o la respiración no es normal, iniciar la reanimación cardiopulmonar.
4	INICIAR COMPRESIONES TORÁCICAS: colocar el talón de la mano en el centro del pecho, entre los pezones. Colocar la segunda mano encima, entrelazando los dedos.
5	Compresiones de calidad: profundidad entre 5 y 6 cm. Frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Permitir que el pecho se expanda completamente entre cada compresión.
6	Ventilaciones con mascarilla de bolsillo: dos ventilaciones de un segundo cada una, después de cada 30 compresiones. Verificar que el tórax se eleve visiblemente. Relación 30 compresiones por 2 ventilaciones.
7	En cuanto llegue el desfibrilador externo automático: encenderlo y seguir las instrucciones de voz. Minimizar las interrupciones en las compresiones al colocar los parches.
8	Si el desfibrilador indica descarga: asegurarse de que nadie toque al paciente y activar la descarga. Reanudar compresiones de inmediato.
9	Continuar la reanimación hasta: llegada del equipo de soporte vital avanzado, recuperación de pulso espontáneo, o agotamiento físico del reanimador.

IMPORTANTE: Cada minuto sin reanimación cardiopulmonar reduce la posibilidad de supervivencia entre un 8 y un 10 %. Iniciar compresiones antes que cualquier otra acción.

SECCIÓN 2 — TRAUMA Y HEMORRAGIAS

UNA HEMORRAGIA MASIVA PUEDE CAUSAR LA MUERTE EN MENOS DE 3 MINUTOS. El control de la hemorragia es la primera acción. Fuente: Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS), 10.^a edición.

Equipamiento — Bolsillo B (color naranja)

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD
Torniquete de combate tipo CAT (Combat Application Tourniquet — torniquete de aplicación en combate), generación 7 o equivalente certificado	2 unidades
Vendaje hemostático con agente de coagulación rápida tipo QuikClot o equivalente	2 unidades selladas individualmente
Vendaje de presión tipo israelita de 10 cm de ancho	2 unidades
Gasa estéril de 10 × 10 cm	10 unidades
Venda elástica de crepé de 10 cm	3 rollos
Esparadrapo	1 rollo
Micropore	1 rollo
Tijera de trauma (corta cinturón, ropa y bota)	1 unidad
Manta de emergencia isotérmica (retiene el calor corporal)	1 unidad
Marcador permanente negro	1 unidad — para anotar la hora exacta del torniquete en la piel del paciente

Protocolo — Control de Hemorragia — Protocolo C-ABCDE

C-ABCDE: Control de hemorragia, Airway (Vía aérea), Breathing (Respiración), Circulation (Circulación), Disability (Estado neurológico), Exposure (Exposición). Basado en el Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS), 10.^a edición.

1	C — CONTROL DE HEMORRAGIA MASIVA: Es la primera acción antes de evaluar la vía aérea. En extremidades: colocar el torniquete 5 a 7 cm por encima de la herida. Ajustar hasta que cese el sangrado. Anotar la hora exacta de colocación en el torniquete y en la piel del paciente con el marcador.
2	A — VÍA AÉREA: Asegurar que la vía aérea esté abierta y permeable. Ver protocolo de la sección 3.
3	B — RESPIRACIÓN: Examinar el tórax. Si hay herida abierta en el tórax, cubrirla con apósito oclusivo sellado en tres lados para evitar el neumotórax a tensión.
4	C — CIRCULACIÓN: Para hemorragias en zonas no comprimibles como el cuello, la axila y la ingle, realizar empaquetamiento de la herida con gasa hemostática aplicando presión directa sostenida durante no menos de 3 minutos.
5	D — ESTADO NEUROLÓGICO: Evaluación rápida con la escala AVPU: Alerta, responde a Voz, responde al dolor (Pain), o sin respuesta (Unresponsive — sin respuesta).
6	E — EXPOSICIÓN: Exponer las lesiones retirando la ropa con la tijera de trauma. Proteger de la hipotermia con la manta isotérmica.

7

Mantener al paciente en posición horizontal. Si no hay sospecha de lesión de columna, elevar las piernas.

8

Activar traslado urgente al centro hospitalario más cercano. No retirar el torniquete en campo bajo ninguna circunstancia.

TORNIQUETE: Anotar la hora exacta de colocación. El tiempo máximo aceptable antes de evaluación por equipo avanzado es de 2 horas. NUNCA aflojar ni retirar el torniquete en el lugar de la emergencia.

SECCIÓN 3 — OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA

SIN OXÍGENO EL CEREBRO SUFRE DAÑO IRREVERSIBLE EN 4 A 6 MINUTOS. La vía aérea libre es prioridad inmediata. Fuente: Guías de la Asociación Americana del Corazón 2020 y Consejo Europeo de Reanimación 2021.

Equipamiento — Bolsillo C (color azul)

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD
Cánula orofaríngea tipo Guedel (dispositivo que mantiene la vía aérea abierta en el paciente inconsciente) talla 3	1 unidad
Cánula orofaríngea tipo Guedel talla 4	1 unidad
Cánula orofaríngea tipo Guedel talla 5	1 unidad
Mascarilla de reanimación de bolsillo con entrada de oxígeno y válvula unidireccional	1 unidad
Bolsa de ventilación manual con mascarilla y reservorio para adulto (bolsa-válvula-mascarilla)	Con válvula de presión positiva. 1 unidad.
Oxígeno portátil en cilindro pequeño	Cilindro de 0,5 litros con regulador de flujo y mascarilla facial. 1 unidad.
Aspirador manual portátil tipo pera (para retirar secreciones y sangre de la boca)	1 unidad
Cánula nasofaríngea con lubricante (dispositivo que mantiene la vía aérea abierta por la nariz)	Talla 28 a 32 French. 1 unidad.
Collar cervical semirígido talla mediana	1 unidad
Collar cervical semirígido talla grande	1 unidad

Protocolo — Manejo de Vía Aérea

1	Evaluar al paciente: ¿Puede hablar? ¿Respira normalmente? ¿Se escuchan ruidos al respirar como gorgoteo, estridor o silencio?
2	PACIENTE INCONSCIENTE SIN TRAUMA: Inclinar la cabeza hacia atrás y elevar el mentón para abrir la vía aérea.
3	PACIENTE INCONSCIENTE CON SOSPECHA DE TRAUMA: Realizar tracción mandibular sin mover el cuello. Colocar el collar cervical.
4	Si hay cuerpo extraño visible en la boca: extraerlo con los dedos únicamente si es visible. No realizar barrido a ciegas.
5	Si hay secreciones o sangre: aspirar antes de ventilar con el aspirador manual portátil.
6	Colocar la cánula orofaríngea del tamaño correcto: medir desde la comisura del labio hasta el lóbulo de la oreja.
7	Ventilación con bolsa de ventilación manual: asegurar sello hermético sobre la cara. Una ventilación cada 5 a 6 segundos. Verificar que el tórax se eleve con cada ventilación.
8	Administrar oxígeno a un flujo de 10 a 15 litros por minuto si se dispone del cilindro portátil.

9

OBSTRUCCIÓN TOTAL EN ADULTO CONSCIENTE: 5 golpes en la espalda entre los omóplatos con el talón de la mano, luego 5 compresiones abdominales hacia adentro y hacia arriba (Maniobra de Heimlich). Repetir hasta expulsar el cuerpo extraño.

10

ADULTO INCONSCIENTE CON OBSTRUCCIÓN: Iniciar reanimación cardiopulmonar 30:2. Revisar la boca antes de cada serie de ventilaciones y extraer el cuerpo extraño si se hace visible.

EMBARAZADA U OBESIDAD SEVERA CON OBSTRUCCIÓN: Reemplazar las compresiones abdominales por compresiones torácicas en el mismo punto que la reanimación cardiopulmonar.

SECCIÓN 4 — ANAFILAXIA

EMERGENCIA QUE PONE EN RIESGO LA VIDA — La adrenalina intramuscular debe administrarse en menos de 5 minutos desde el inicio de los síntomas. Fuente: Organización Mundial de Alergia 2020.

Equipamiento — Bolsillo D (color morado)

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD
Adrenalina — Epinefrina — ampollas solución 1 en 1000 (1 mg por mililitro)	4 ampollas. Verificar fecha de vencimiento antes de cada turno.
Jeringas de 1 mililitro con aguja 25 gauges de 16 mm para inyección intramuscular	4 unidades
Clorofeniramina (antihistamínico de segunda línea) ampollas 10 mg por mililitro	2 ampollas
Hidrocortisona (corticosteroide de segunda línea) ampollas de 100 mg	4 ampollas — permite administrar dosis de 100 a 200 mg según la situación clínica
Torniquete venoso de jebe o látex	2 unidades
Catéter intravenoso número 18 (para venas de buen calibre)	2 unidades
Catéter intravenoso número 20 (para venas de calibre mediano)	2 unidades
Solución salina — cloruro de sodio al 0,9 % — minibolsa de 100 mililitros	2 unidades
Torundas de algodón con alcohol isopropílico al 70 %	20 torundas
Autoinyector de adrenalina (alternativa si no hay ampollas disponibles en ese momento)	2 unidades, una para adulto y una para niño

Nota: El autoinyector de adrenalina debe usarse en lugar de las ampollas cuando estas no están disponibles, no de manera adicional a ellas.

Protocolo — Atención de Anafilaxia

Basado en las Guías de la Organización Mundial de Alergia 2020 y la Guía NICE NG80 2020.

1	RECONOCER LA ANAFILAXIA: Aparición súbita de signos en la piel como urticaria generalizada o inflamación de la cara y la garganta, combinados con dificultad para respirar o caída brusca de la presión arterial, tras contacto con un alérgeno como un medicamento, alimento, picadura o veneno.
2	ADRENALINA INTRAMUSCULAR INMEDIATA: Adulto y adolescente mayor de 30 kg: 0,3 a 0,5 mg (0,3 a 0,5 mililitros de la solución 1:1000). Niño menor de 30 kg: 0,01 mg por kilogramo de peso. Lugar de inyección: cara anterolateral del muslo, en el músculo vasto externo. Inyección intramuscular profunda.
3	Retirar o interrumpir el alérgeno si es posible: retirar el aguijón, suspender el medicamento que se estaba administrando.
4	Posición del paciente: decúbito supino (boca arriba) con piernas elevadas si hay hipotensión. Si hay dificultad para respirar: semisentado. Embarazada: decúbito lateral izquierdo.

5	Llamar al Sistema de Emergencias Médicas (SAMU 106) de inmediato. Administrar oxígeno a 10-15 litros por minuto.
6	Canalizar vía venosa. Administrar solución salina rápida si hay hipotensión.
7	Si no hay mejoría en 5 a 15 minutos → segunda dosis de adrenalina intramuscular con la misma dosis.
8	MEDICAMENTOS DE SEGUNDA LÍNEA — solo después de administrar la adrenalina: Clorfeniramina 10 mg intramuscular. Hidrocortisona 100 a 200 mg intravenoso o intramuscular (usar 1 o 2 ampollas según necesidad).
9	Monitoreo continuo de signos vitales. Existe riesgo de reacción en segunda fase hasta 72 horas después del episodio.

La adrenalina intramuscular ES el tratamiento de primera elección y no puede sustituirse por ningún otro medicamento. Los antihistamínicos y los corticosteroides son complementarios, NUNCA son la primera opción en anafilaxia.

SECCIÓN 5 — CRISIS HIPERTENSIVA / HIPOGLUCEMIA

HIPOGLUCEMIA: glucosa en sangre menor a 70 mg/dL (miligramos por decilitro) es una emergencia médica. **CRISIS HIPERTENSIVA:** presión arterial mayor a 180/120 mmHg (milímetros de mercurio) requiere evaluación urgente.

Equipamiento — Bolsillo E (color verde) — exclusivo de esta sección

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD
Glucómetro portátil con tiras reactivas y lancetas	1 equipo completo + 10 tiras reactivas + 10 lancetas
Glucosa oral en tabletas o gel de absorción rápida	Tabletas de 15 gramos. 3 porciones.
Dextrosa al 33 % en ampollas de 20 mililitros (azúcar concentrada para uso intravenoso)	3 ampollas vigentes
Tensiómetro digital automático portátil	1 unidad con manguito para adulto
Oxímetro de pulso digital de dedo (mide el nivel de oxígeno en la sangre)	1 unidad con batería cargada
Nifedipino cápsulas de 10 mg (medicamento para bajar la presión arterial)	4 cápsulas — uso solo bajo protocolo institucional autorizado
Nitroglicerina sublingual (medicamento vasodilatador de acción rápida)	1 frasco — uso solo bajo protocolo institucional autorizado

Los catéteres intravenosos, el torniquete venoso y la solución salina están en el bolsillo D. No se duplican en este bolsillo.

Protocolo — Hipoglucemia (nivel bajo de azúcar en sangre)

Basado en los Estándares de Atención de la Asociación Americana de Diabetes 2024.

1	Medir la glucosa en sangre capilar con el glucómetro. Valor menor a 70 mg/dL confirma hipoglucemia. Valor menor a 40 mg/dL indica hipoglucemia severa.
2	PACIENTE CONSCIENTE Y PUEDE TRAGAR: Administrar 15 a 20 gramos de glucosa de absorción rápida por la boca: 3 a 4 tabletas de glucosa, gel de glucosa, o 150 mililitros de jugo de fruta natural.
3	Repetir la medición de glucosa a los 15 minutos. Si sigue siendo menor a 70 mg/dL → repetir la dosis oral.
4	PACIENTE INCONSCIENTE O NO PUEDE TRAGAR: No dar nada por la boca. Administrar dextrosa al 33 %, 40 a 60 mililitros por vía intravenosa lenta.
5	Después de la recuperación: asegurar que el paciente ingiera un refrigerio con carbohidratos de absorción lenta para evitar recaída. Activar traslado al establecimiento de salud.

Protocolo — Crisis Hipertensiva (presión arterial muy elevada)

Basado en las Guías de Hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Hipertensión 2018.

1	Medir la presión arterial en ambos brazos con el paciente sentado en reposo durante 5 minutos.
---	--

2	URGENCIA HIPERTENSIVA: Presión arterial sistólica (número superior) mayor a 180 o diastólica (número inferior) mayor a 120 mmHg, SIN signos de daño a órganos vitales. El paciente está estable.
3	EMERGENCIA HIPERTENSIVA: Mismos valores de presión arterial MÁS alguno de estos síntomas: cefalea intensa, visión borrosa, dolor en el pecho, dificultad para respirar, confusión, parálisis o debilidad en un lado del cuerpo.
4	Ante EMERGENCIA HIPERTENSIVA: Activar traslado INMEDIATO. No reducir la presión arterial bruscamente en campo, ya que puede causar isquemia cerebral o cardíaca.
5	Ante URGENCIA HIPERTENSIVA sin síntomas de daño orgánico: reposo en posición semisentada, reevaluar la presión arterial en 30 minutos, traslado programado.
6	El Nifedipino sublingual o la nitroglicerina solo deben utilizarse bajo protocolo institucional autorizado.
7	Monitoreo continuo de presión arterial, saturación de oxígeno y estado neurológico durante todo el traslado.

SECCIÓN 6 — CONVULSIONES

CONVULSIÓN DE MÁS DE 5 MINUTOS O CONVULSIONES REPETIDAS SIN RECUPERACIÓN DEL CONOCIMIENTO = ESTATUS EPILÉPTICO. Constituye una emergencia neurológica grave. Fuente: Liga Internacional contra la Epilepsia 2017 y Academia Americana de Neurología.

Equipamiento — Bolsillo D (color morado) y Bolsillo C (color azul)

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD
Midazolam (benzodiazepina — medicamento anticonvulsivante de primera línea prehospitalaria) ampollas 5 mg por mililitro — para uso intramuscular o intranasal	4 ampollas vigentes
Jeringa de 1 mililitro y atomizador nasal MAD (Mucosal Atomization Device — dispositivo para atomizar medicamentos en la mucosa nasal) para administración intranasal	2 unidades
Diazepam (benzodiazepina anticonvulsivante) en solución rectal de 10 mg — alternativa cuando no es posible la vía intramuscular	2 unidades vigentes
Cánulas orofaríngeas tipo Guedel — tallas 3, 4 y 5	Ya incluidas en el bolsillo C. Verificar disponibilidad.
Oxímetro de pulso de dedo	Ya incluido en el bolsillo E. Verificar disponibilidad.
Glucómetro portátil	Ya incluido en el bolsillo E. Verificar disponibilidad.
Collar cervical semirígido	Ya incluido en el bolsillo C. Verificar disponibilidad.

Protocolo — Manejo de Convulsiones

1	PROTEGER al paciente del entorno: retirar objetos peligrosos cercanos. Colocar algo blando y plano bajo la cabeza.
2	NO sujetar al paciente con fuerza ni intentar inmovilizar las extremidades. NO introducir ningún objeto en la boca durante la convulsión.
3	Registrar la hora exacta de inicio de la convulsión desde el primer momento.
4	Cuando la convulsión ceda: colocar al paciente en posición lateral de seguridad, con la cara mirando hacia el suelo, para prevenir la aspiración de secreciones.
5	SI LA CONVULSIÓN DURA MÁS DE 5 MINUTOS: administrar medicamento anticonvulsivante.
6	MIDAZOLAM INTRAMUSCULAR: Adulto — 0,1 a 0,2 mg por kilogramo de peso (habitualmente entre 5 y 10 mg según el peso del paciente). Niño — 0,2 mg por kilogramo de peso. Lugar: cara anterolateral del muslo.
7	MIDAZOLAM INTRANASAL con atomizador: 0,2 mg por kilogramo de peso (máximo 10 mg). Dividir la dosis en partes iguales entre ambas fosas nasales.
8	Si no se dispone de Midazolam: Diazepam rectal 10 mg en adulto. En niño: 0,5 mg por kilogramo de peso.
9	Medir la glucosa en sangre. Si hay hipoglucemia → corregir según el protocolo de la sección 5.
10	Administrar oxígeno a 10-15 litros por minuto. Tener preparada la bolsa de ventilación manual por si hay pausa respiratoria después de la convulsión.

11

Activar traslado urgente. Documentar: hora de inicio, duración total, tipo de movimientos observados, medicamentos y dosis administradas.

PROHIBIDO: No introducir objetos en la boca durante la convulsión. Es un mito que el paciente pueda tragarse la lengua. Los depresores linguales están CONTRAINDICADOS durante la crisis.

LISTA DE VERIFICACIÓN Y REPOSICIÓN — POST INTERVENCIÓN

Completar ANTES de retornar al servicio activo. El maletín debe estar listo para la siguiente emergencia.

N.º	ARTÍCULO A VERIFICAR	CANTIDAD	COMPLETO	REPONER
BOLSILLO A — COLOR ROJO				
1	Mascarilla de reanimación de bolsillo con válvula unidireccional, sin daño físico	1	☐	☐
2	Desfibrilador externo automático — parches sin abrir, batería cargada	1 equipo	☐	☐
3	Parches de repuesto para desfibrilador — juego adulto	1 juego	☐	☐
4	Parches de repuesto para desfibrilador — juego pediátrico	1 juego	☐	☐
5	Guantes de nitrilo talla mediana	4 pares	☐	☐
6	Guantes de nitrilo talla grande	4 pares	☐	☐
7	Hoja de registro rápido de atención en blanco	2 copias	☐	☐
8	Lapicero negro	1	☐	☐
BOLSILLO B — COLOR NARANJA				
9	Torniquete de combate tipo CAT — faja limpia y sin daño	2	☐	☐
10	Gasa hemostática — envase sellado e íntegro	2	☐	☐
11	Vendaje de presión israelita de 10 cm	2	☐	☐
12	Gasa estéril de 10 × 10 cm	10	☐	☐
13	Venda elástica de crepé de 10 cm	3 rollos	☐	☐
14	Esparadrapo	1 rollo	☐	☐
15	Micropore	1 rollo	☐	☐
16	Tijera de trauma — limpia y funcional	1	☐	☐
17	Manta de emergencia isotérmica	1	☐	☐
18	Marcador permanente negro	1	☐	☐
BOLSILLO C — COLOR AZUL				
19	Cánula orofaríngea tipo Guedel talla 3	1	☐	☐
20	Cánula orofaríngea tipo Guedel talla 4	1	☐	☐
21	Cánula orofaríngea tipo Guedel talla 5	1	☐	☐
22	Cánula nasofaríngea con lubricante	1	☐	☐
23	Bolsa de ventilación manual adulto — válvula funcional, reservorio limpio	1	☐	☐
24	Cilindro de oxígeno portátil — mínimo 50 % de carga	1	☐	☐
25	Aspirador manual portátil	1	☐	☐

26	Collar cervical semirígido talla mediana	1	☐	☐
27	Collar cervical semirígido talla grande	1	☐	☐
BOLSILLO D — COLOR MORADO				
28	Adrenalina 1:1000 — ampollas dentro de fecha de vencimiento	4 ampollas	☐	☐
29	Clorofeniramina 10 mg/mililitro — ampollas vigentes	2 ampollas	☐	☐
30	Hidrocortisona 100 mg — ampollas vigentes	4 ampollas	☐	☐
31	Jeringas de 1 mililitro con aguja intramuscular	4	☐	☐
32	Midazolam 5 mg por mililitro — ampollas vigentes	4 ampollas	☐	☐
33	Atomizador nasal para Midazolam intranasal	2	☐	☐
34	Diazepam rectal 10 mg — vigente	2	☐	☐
35	Catéter intravenoso número 18	2	☐	☐
36	Catéter intravenoso número 20	2	☐	☐
37	Torniquete venoso de jebe o látex	2	☐	☐
38	Solución salina 0,9 % minibolsa de 100 mililitros	2 bolsas	☐	☐
39	Torundas de algodón con alcohol isopropílico al 70 %	20	☐	☐
BOLSILLO E — COLOR VERDE				
40	Glucómetro portátil — batería cargada	1	☐	☐
41	Tiras reactivas para glucómetro — vigentes	10	☐	☐
42	Lancetas	10	☐	☐
43	Glucosa oral en tabletas o gel	3 porciones	☐	☐
44	Dextrosa al 33 % en ampollas — vigentes	3 ampollas	☐	☐
45	Tensiómetro digital automático — batería cargada	1	☐	☐
46	Oxímetro de pulso de dedo — batería cargada	1	☐	☐
47	Nifedipino 10 mg cápsulas — vigentes	4 cápsulas	☐	☐

Fecha:

Nombre del responsable:

Firma:

____ / ____ / ____

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BASE EVIDENCIAL

Todas las recomendaciones de este maletín están respaldadas por guías clínicas internacionales vigentes y han sido adaptadas al contexto del sistema de salud peruano.

FUENTE	PUBLICACIÓN Y AÑO	APLICA A
Guías de la Asociación Americana del Corazón 2020	Circulation. 2020; volumen 142, suplemento 2.	Paro cardiorrespiratorio, reanimación básica y avanzada, vía aérea
Guías del Consejo Europeo de Reanimación 2021	Resuscitation. 2021; volumen 161, páginas 1 a 60.	Paro cardiorrespiratorio, vía aérea, anafilaxia
Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS), 10.ª edición. Colegio Americano de Cirujanos.	Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2018.	Trauma, hemorragia, protocolo C-ABCDE
Guías de la Organización Mundial de Alergia para Anafilaxia 2020	World Allergy Organization Journal. 2020; volumen 13, número 8.	Anafilaxia en adultos y niños
Guía NICE NG80 para Anafilaxia 2020	NICE, Reino Unido. 2020.	Anafilaxia
Clasificación de las Epilepsias. Liga Internacional contra la Epilepsia 2017	Epilepsia. 2017; volumen 58, número 4, páginas 512 a 521.	Convulsiones y estatus epiléptico
JNC 8 — Octavo Reporte del Comité Nacional Conjunto sobre Hipertensión	JAMA. 2014; volumen 311, número 5, páginas 507 a 520.	Crisis hipertensiva — referencia histórica
Guías de Hipertensión Arterial de la Sociedad Europea de Cardiología 2018	European Heart Journal. 2018; volumen 39, número 33, páginas 3021 a 3104.	Crisis hipertensiva — guía vigente
Estándares de Atención de la Asociación Americana de Diabetes 2024	Diabetes Care. 2024; volumen 47, suplemento 1.	Hipoglucemia
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales del Perú — versión vigente	Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial vigente.	Disponibilidad y uso de medicamentos en el Perú

AVISO: Este documento es un instrumento operativo de referencia rápida para personal capacitado. No reemplaza el juicio clínico del profesional de salud, los protocolos institucionales vigentes ni las normas del Ministerio de Salud del Perú.